

Amniorrexe prematura - conduta

RPM = rotura de membranas antes do trabalho de parto. Confirme perda de líquido, estime IG, exclua infecção e balanceie latência (corticoide/ATB) vs interrupção.

Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

História de escape líquido + especular (líquido no fundo de saco). Testes auxiliares (pH/nitrazina, IGFBP-1) e oligodrômio apoiam. Evite toques repetidos.

Timeline: diagnóstico !' profilaxia e corticoides se prematuro !' parto se termo, infecção ou maturidade conforme protocolo.



Conduta por idade gestacional (ideia)

- Termo ("e37 sem): interromper — indução se sem contraindicação
- Pré-termo: corticoide, ATB de latência, monitoramento de infecção/sofrimento
- Corioamnionite: ATB + interrupção independentemente da IG
- Profilaxia GBS conforme protocolo se em trabalho de parto / cultura

Sinais de corioamnionite

Sinal | Nota

Febre materna | Critério central

Taquicardia materno-fetal | Apoio

Útero doloroso / líquido fétido | Infecção intra-amniótica

Leucocitose | Inespecífico — correlacionar

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Com corioamnionite não se 'prolonga latência para amadurecer pulmão'. Antibiótico e resolução da gestação têm prioridade sobre expectativa.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1